REALTÀ VIRTUALE IN REPARTO

LINEE GUIDA CONSORT · BMJ



Prima di accendere un visore, cinque domande

Quelle che poniamo con ogni ospedale partner. Sfoglia →



Dott. Matteo Era

Medico Chirurgo · Head of Clinical R&D · Lemons in the Room

Lemons in the room

IL PUNTO

Un visore si compra in un giorno. Un intervento si costruisce.

Consegnare un visore senza regole produce entusiasmo per qualche giorno, ma nessun dato utilizzabile.

SOLO L'OGGETTO

Iniziativa occasionale

Nessuna indicazione precisa, flusso lasciato al singolo turno, nessun esito misurato.

CON UN PROTOCOLLO

Intervento clinico

Popolazione, tempi, igiene, sicurezza ed endpoint definiti prima del primo paziente.

DOMANDA 1

Per chi, e quando?



Quali pazienti, quale procedura clinica e in quale finestra temporale: in attesa, durante la manovra o subito dopo.

DALLA LETTERATURA

Nei bambini, **16 studi su 17** hanno impiegato la realtà virtuale come distrazione attiva durante l'esecuzione della procedura.

Eijlers et al., Anesthesia & Analgesia 2019;129:1344-53

DOMANDA 2

Chi lo fa, e con quanto tempo?



Chi consegna il visore, chi avvia la sessione sul tablet e chi raccoglie le scale cliniche.

REGOLA DI REPARTO

Ogni passaggio chiesto a medici e infermieri deve durare pochi minuti ed essere sostenibile nel turno reale, non solo sulla carta.

DOMANDA 3

Come si sanifica?



Una procedura scritta, rapida e tracciabile tra un paziente e l’altro.

CONTROLLO INFEZIONI

Superfici non porose, panni disinfettanti ospedalieri e istruzioni validate con la direzione sanitaria prima di iniziare l’arruolamento.

DOMANDA 4

Chi non dovrebbe usarlo?



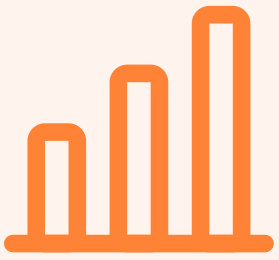
Criteri di esclusione chiari nel protocollo e nelle istruzioni d’uso del dispositivo.

SICUREZZA DEL PAZIENTE

Regola immediata per tutta l’équipe: se compaiono nausea, vertigini o fastidio visivo, la sessione si interrompe subito.

DOMANDA 5

Che cosa misuriamo?



Un quesito primario, uno strumento validato e una finestra di tempo coerente con la durata della procedura.

METODO

L’ansia e il dolore acuti si misurano al letto del paziente con scale di stato brevi, subito prima e subito dopo la manovra.

IN SINTESI

I cinque pilastri prima di iniziare

1 **Per chi, e quando**
Popolazione, procedura e finestra d’intervento

2 **Chi lo fa, e con quanto tempo**
Ruoli in corsia e carico operativo sostenibile

3 **Come si sanifica**
Procedura condivisa con il controllo infezioni

4 **Chi non dovrebbe usarlo**
Criteri di esclusione e gestione della tollerabilità

5 **Che cosa misuriamo**
Endpoint primario e scala validata nel momento giusto

Dott. Matteo Era
Head of Clinical Research and Development · Lemons in the Room

LA VOSTRA ESPERIENZA

Quale domanda aggiungereste?



Se state valutando di portare o studiare la realtà virtuale nel vostro reparto, salvate questo documento come traccia operativa.

CONFRONTO TRA COLLEGHI

Qual è l'aspetto pratico che nel vostro reparto pesa di più quando si introduce un nuovo dispositivo? Scrivetelo nei commenti.